

Cours De Résidanat

Sujet : 18

Contraception

Pr Faten Hachéni Pr Ag Ons Kaabia Dr Sirine Chelly

Questions à choix multiples & Cas Cliniques

Session Aout 2025

Questions à choix multiples

Objectif 1 : Définir la contraception.

1. La contraception se définit comme :
 - A. L'interruption volontaire de grossesse
 - B. L'ensemble des méthodes visant à éviter une grossesse non désirée
 - C. L'aménorrhée secondaire
 - D. La stérilisation chirurgicale uniquement
 - E. L'abstinence sexuelle totale

2. Lequel des énoncés suivants est correct concernant la définition de la contraception ?
 - A. Elle concerne uniquement les méthodes hormonales
 - B. Elle regroupe les méthodes temporaires ou définitives pour éviter la grossesse
 - C. Elle ne concerne que les femmes en âge de procréer
 - D. Elle est synonyme de contraception d'urgence
 - E. Elle ne concerne que les couples mariés

3. Concernant la contraception, choisir la ou les bonnes réponses
 - A. C'est l'ensemble des méthodes utilisées pour éviter, de façon irréversible et/ou temporaire une grossesse non désirée.
 - B. C'est l'ensemble des méthodes utilisées pour éviter, de façon temporaire une grossesse non désirée.
 - C. C'est l'ensemble des méthodes utilisées pour éviter, de façon irréversible une grossesse non désirée.
 - D. Permet d'espacer les grossesses.
 - E. Est un acquis social.

Objectif 2 : Décrire les différents moyens de contraception.

4. Parmi les méthodes suivantes, lesquelles sont considérées comme des contraceptifs mécaniques ?
 - A. Préservatif masculin
 - B. DIU au cuivre
 - C. Implant contraceptif
 - D. Diaphragme
 - E. Pilule combinée
5. Laquelle des propositions suivantes correspond à une méthode contraceptive hormonale ?
 - A. Stérilet au cuivre
 - B. Anneau vaginal
 - C. Préservatif féminin
 - D. Ligature tubaire
 - E. Spermicides
6. Quelles sont parmi les méthodes contraceptives celles qui assurent une prévention des maladies sexuellement transmissibles :
 - A. La méthode des températures.
 - B. Le préservatif.
 - C. Les oestro-progestatifs.
 - D. Le stérilet.
 - E. Les ovules spermicides.
7. Concernant la pose d'un DIU :
 - A. Elle ne peut se faire qu'entre J14 et le 1er jour des règles.
 - B. Elle est conseillée 6 semaines après le retour de couches après un avortement.
 - C. Elle est conseillée immédiatement après un avortement.
 - D. Elle est conseillée dans les 7 jours après un rapport non protégé pour une contraception d'urgence.
 - E. Elle doit être faite toujours avant un toucher vaginal

Objectif 3 : Expliquer les bases pharmacologiques de la contraception hormonale.

8. Concernant les contraceptifs hormonaux combinés, le mode d'action principal est :
 - A. Inhibition de l'ovulation
 - B. Modification de la glaire cervicale uniquement
 - C. Inflammation de l'endomètre
 - D. Destruction directe des spermatozoïdes
 - E. Empêchement de la nidation uniquement

9. A quel(s) niveau(x) agissent les oestro-progestatifs combinés :
 - A. Au niveau de l'hypophyse en bloquant le pic de LH.
 - B. Au niveau de l'hypophyse en augmentant le taux de prolactine.
 - C. Au niveau de l'endomètre qui est hypertrophié et impropre à la nidation
 - D. Au niveau du col qui secrète une glaire abondante de type estrogénique.
 - E. Au niveau de l'hypophyse en bloquant le pic de LH et création d'un pic de FSH.

10. Les progestatifs seuls agissent principalement par :
 - A. Blocage de la maturation folliculaire
 - B. Augmentation de la température corporelle basale
 - C. Modification de la glaire cervicale et de l'endomètre
 - D. Effet anti-œstrogénique direct sur l'hypophyse
 - E. Action cytotoxique sur l'ovocyte

11. Choisir la ou les propositions vraies concernant les DIU au lévonogestrel :
 - A. C'est le moyen contraceptif le plus utilisé en Tunisie.
 - B. C'est un contraceptif.
 - C. Il doit être retiré tous les 3 ans
 - D. Il liquéfie la glaire cervicale.
 - E. Il est responsable d'une réaction inflammatoire au niveau du myomètre

Objectif 4 : Préciser l'efficacité (indice de PEARL) des différents moyens de contraception en fonction du mode d'action.

12. L'indice de Pearl mesure :

- A. L'efficacité d'une méthode contraceptive
- B. Le taux d'ovulation sous contraception
- C. La tolérance d'une méthode contraceptive
- D. La fréquence des effets secondaires
- E. La satisfaction des patientes

13. Parmi les méthodes suivantes, laquelle présente le plus faible indice de Pearl (meilleure efficacité) ?

- A. Préservatif masculin
- B. Implant contraceptif
- C. Coït interrompu
- D. Spermicides seuls
- E. Méthode du calendrier

Objectif 5 : Justifier le choix d'une méthode contraceptive en fonction du bilan clinique et paraclinique de la patiente.

14. Chez une patiente hypertendue et fumeuse de 40 ans, la méthode contraceptive à éviter est :
- A. Pilule œstroprogestative combinée
 - B. DIU au cuivre
 - C. Préservatif
 - D. Implant progestatif
 - E. Méthode de l'ovulation
15. Le choix d'une méthode contraceptive doit prendre en compte :
- A. L'âge de la patiente
 - B. Les antécédents médicaux
 - C. Le désir de grossesse ultérieur
 - D. La tolérance et l'adhésion de la patiente
 - E. Uniquement les préférences du médecin
16. Parmi les propositions suivantes laquelle est une CI relative au DIU en cuivre :
- A. Les troubles de l'hémostase.
 - B. La maladie de Wilson.
 - C. L'infection génitale haute.
 - D. Une maladie mitrale.
 - E. Une prothèse aortique
17. Dans la liste ci-dessous, indiquez les contre-indications absolues du stérilet en cuivre :
- A. Les infections cervico-vaginales.
 - B. Les cardiopathies valvulaires.
 - C. La prise d'antiépileptiques.
 - D. Le diabète bien équilibré.
 - E. Les ménorragies.

Objectif 6 : Détailler les modalités de surveillance clinique et biologique d'une femme sous contraception hormonale ou mécanique.

18. La surveillance d'une patiente sous contraception hormonale combinée inclut :
- A. Mesure régulière de la tension artérielle
 - B. Bilan hépatique
 - C. Dépistage du diabète gestationnel
 - D. Évaluation du poids et IMC
 - E. Recherche systématique d'IST
19. La prescription d'une pilule oestro-progestative à 35mg d'éthinyl oestradiol chez une femme de 30 ans a des contre-indications. Indiquez parmi les contre-indications ci-dessous celle qui ne constitue pas une contre-indication absolue :
- A. Tension artérielle à 16/10 sous traitement bien conduit.
 - B. Antécédents d'HTA gravidique
 - C. Diabète insulino-dépendant bien équilibré au stade de microangiopathie.
 - D. Lupus érythémateux évolutif
 - E. Antécédent de phlébite après l'accouchement
20. Vous suivez une patiente de 35 ans sous oestro-progestatifs à 35mg. Indiquez parmi ces résultats du bilan qui lui a été pratiqué lors de la surveillance, ceux qui justifient l'arrêt de la prescription des oestro-progestatifs :
- A. Tension artérielle de 13/08
 - B. Cholestérol à 6,5 mmol/l.
 - C. Triglycéride à 1,2 mmol/l.
 - D. Glycémie postprandiale à 6 mmol/l.
 - E. Frottis CIN2.
21. Chez une femme porteuse d'un DIU au cuivre, la surveillance recommandée comprend :
- A. Vérification des fils du DIU
 - B. Contrôle échographique annuel
 - C. Dosage hormonal trimestriel
 - D. Palpation mammaire mensuelle
 - E. Frottis cervico-vaginal selon les recommandations

22. Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui est inexacte :

- A. Un traitement barbiturique diminue l'efficacité de la contraception orale.
- B. Une aménorrhée pendant 1 an après la prise d'oestroprogestatif, peut être due à l'effet atrophiant prolongé de la pilule sur l'endomètre.
- C. Le tabagisme augmente le risque vasculaire des oestro-progestatifs.
- D. Un antécédent de thrombophlébite contre indique formellement la prescription d'oestro-progestatifs.
- E. L'adénome hépatique est une complication possible des oestro-progestatifs.

Objectif 7 : Préciser les moyens et les modalités d'utilisation d'une contraception d'urgence (contraception du lendemain).

23. La contraception d'urgence au lévonorgestrel est efficace si prise :
- A. Dans les 12 h suivant le rapport
 - B. Dans les 24 h
 - C. Dans les 72 h
 - D. Dans les 5 jours
 - E. Uniquement avant l'ovulation
24. Parmi les méthodes suivantes, laquelle est la plus efficace comme contraception d'urgence ?
- A. DIU au cuivre
 - B. Lévonorgestrel 1,5 mg
 - C. Ulipristal acétate
 - D. Coït interrompu
 - E. Double dose de pilule combinée

Cas cliniques

Cas clinique 1

Madame T, 38 ans, mère de 3 enfants, a un stérilet en cuivre depuis 2 ans. Elle vous consulte à titre systématique pour sa surveillance, sa date des dernières règles remonte à 10 jours.

A l'examen:

Au spéculum: vous ne voyez pas de fil de stérilet.

Le Toucher vaginal est normal

1. Quelles sont les raisons possibles de la disparition du fil?

- A. Expulsion du stérilet
- B. La survenue d'une grossesse
- C. Perforation avec migration du stérilet
- D. Section du fil du stérilet
- E. Ascension du fil dans la cavité utérine

2. Quels examens complémentaires pouvez-vous faire pour préciser la topographie du stérilet

- A. Une hystérosalpingographie
- B. Une échographie pelvienne
- C. Une radiographie de l'abdomen sans préparation
- D. Une hystéroscopie
- E. Une coelioscopie

3. Quelles autres complications possibles peuvent être imputées au DIU ?

- A. Infection génitale haute
- B. Infection génitale basse
- C. Trouble métabolique
- D. Prise de poids
- E. Grossesse extra utérine

4. Le DIU peut :

- A. Migrer dans la cavité abdominale
- B. Migrer dans le mur utérin
- C. S'expulser
- D. Avoir une toxicité nucléaire chez le spermatozoïde
- E. Avoir une toxicité mitochondriale chez le spermatozoïde

5. Constitue une contre-indication à la remise de DIU au lévonorgestrel :

- A. Un antécédent de IGH à répétition
- B. Un diabète type 1
- C. Un antécédent de GEU
- D. Une HTA déséquilibrée
- E. Un antécédent de cancer du sein

Cas Clinique 2

Madame Z., 38 ans G3P3A0, 3 enfants vivants, HTA sous bithérapie, décrit des troubles de l'humeur à type d'irritabilité suite à la prise d'oestroprogestatifs à visée contraceptive avec prise de poids gênante, elle vient vous consulter pour meilleur moyen contraceptif efficace.

1. Sa contraception initiale aux oestroprogestatifs :

- A. est appropriée pour son cas
- B. est une contre indication absolue en cas de HTA
- C. est responsable de sa prise de poids
- D. explique ses troubles de l'humeur
- E. peut être substituée par un microprogestatif

2. Quel moyen contraceptif proposer :

- A. Le DIU pour l'âge, HTA et tolérance
- B. Les microprogestatifs qui ne provoquent pas de prise de poids
- C. Le DIU pour une femme qui est multipare
- D. La contraception mécanique pour son efficacité optimale avec un indice de PEARL supérieur
- E. Le DIU au cuivre avec sa toxicité ribosomale chez les spermatozoïdes

3. L'hypertension artérielle :

- A. Est une contre indication relative aux oestroprogestatifs
- B. Est une contre indication absolue aux oestroprogestatifs si HTA non contrôlée
- C. L'association aux oestroprogestatifs mini dosés n'augmente pas le risque thromboembolique
- D. L'association aux microprogestatifs n'augmente pas le risque thromboembolique
- E. Implique un bilan lipidique avant toute contraception hormonale

4. Chez cette patiente de 38 ans :

- A. Les oestroprogestatifs sont une contre indication absolue
- B. Les oestroprogestatifs sont une contre indication relative
- C. Les oestroprogestatifs sont une contre indication absolue si tabagisme associé
- D. Le DIU est la méthode contraceptive de choix
- E. Pas de sur risque du cancer du sein si association aux oestro-progestatifs à cet âge relativement jeune.

5. L'examen clinique pour cette patiente :

- A. L'interrogatoire doit préciser si la patiente est tabagique
- B. La notion d'antécédent de GEU ne change pas le choix contraceptif en faveur des oestroprogestatifs
- C. La notion d'antécédent de GEU ne change pas le choix contraceptif en faveur du DIU
- D. L'examen des seins dispense d'une exploration écho-mammographique initiale
- E. Le FCV obligatoire n'intervient pas dans le choix de la méthode contraceptive.

Cas Clinique 3

Madame L, 40 ans, G4P4A0, sans antécédents ni moyens contraceptifs particuliers, utilise parfois la méthode d'abstinence périodique, vous consulte rapportant la notion de rapport à J9, réalisant le risque de grossesse, elle vient demander votre conseil pour une contraception d'urgence.

1. La méthode du calendrier :

- A. a été respectée par la patiente vu l'éviction entre J10 et J 18
- B. est appelée aussi méthode Billings
- C. est appelée aussi méthode Ogino-Knaus
- D. a un indice de PEARL à 1,5
- E. résulte en 150 grossesses si 1000 femmes utilisent cette méthode pendant un an.

2. La contraception d'urgence :

- A. est non justifiée à J 9
- B. est d'ordre hormonal, essentiellement progestative
- C. hormonale, elle comprend des oestroprogestatifs à forte dose
- D. hormonale, elle comprend des progestatifs à forte dose
- E. comprend le recours au DIU

3. Le Norlévo®:

- A. est un progestatif de 2ème génération
- B. peut être administré et aussi efficace jusqu'au 5ème jour suite à un rapport à risque
- C. comprend 1, 5 mg de lévonorgestrel
- D. est moins efficace que le Ellaone®
- E. est plus efficace que le DIU

4. Le DIU :

- A. est le moyen contraceptif d'urgence le plus efficace
- B. à poser dans la semaine suite au rapport à risque
- C. est souhaitable chez l'adolescente
- D. à garder comme moyen contraceptif chez cette patiente
- E. agit par effet inflammatoire sur l'endomètre et toxique sur le spermatozoïde

5. Après la contraception d'urgence :

- A. conseiller un oestroprogestatif minidosé chez cette patiente
- B. conseiller un DIU
- C. refaire un bilan hormonal avant d'instaurer une contraception chez cette patiente
- D. un microprogestatif est la méthode de choix chez cette patiente sachant qu'elle a eu un antécédent de phlébite du membre inférieure
- E. le DIU est moins efficace que les microprogestatifs